



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض رابعياً : حميده سيد عبد الباسط موسي

المحافظة : اسوان الحى / المدينة : ادفو

رقم البطاقة : 26806262800205 رقم التليفون : 01244971652

العمر (تاريخ الميلاد) : 26-06-1968 المهنة : ربه منزل

العنوان : ادفو

تاريخ تسجيل الإستمارة : 29-09-2026

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط اول تاموكسيفين قسم العلاج : [14160]

التعليق على التشخيص : -----

خطاب إداري

هذا الرقم القومي يتبع منظومة التأمين الصحي الشامل جهة الاختصاص



--

Name: حميدة سيد عبد الباسط موسى National ID: 26806262800205	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Tamoxifen therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطالة تحقيق الشخصية

حميدة
سيد عبد الباسط موسى
الرمادي قليس - ابوصادق
مركز ادفو - السوان

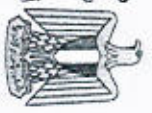
٢٦٨٠٦٢٦٢٨٠٠٢٠٥

IB2169115



139

٢٠١٩/٠٧ ٢٦٨٠٦٢٦٢٨٠٠٨٠٥
ربة منزل
انثى
مسلمة
محمد صالح محمد حسين
متزوجة
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٠٧/١٥



Name: حميده سيد عبد الباسط موسي			
MR. : 7137			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحيه طيبه وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient presented today for continuation of tamoxifen therapy, with a plan for supportive treatment for an additional three months. The patient's breast cancer status is ER 0/8, PR 2/8, HER2 +3, currently on adjuvant tamoxifen initiated in February 2023. Imaging in July 2026 shows a BIRADS 1 assessment and an unremarkable ultrasound. The plan remains tamoxifen plus supportive care for three months, with the next visit scheduled for 17 October 2026.			
تحريرا في ,			
التاريخ :		20-09-2026	
الوقت :			
Reham Ahmed Fathy Ibrahim		الطبيب المعالج :	
يعتمد ,			

Patient Name : الأستاذة / حميدة سيد عبدالباست موسى	Request No. : 13003670
Patient No. : 26806262800205	Request Date : 12/01/2023
Path No. : 110/2023	Verification Date : 24/01/2023
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 54 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post chemotherapy.

Nature of the specimen: Left MRM specimen.

Gross Examination:

- Procedure: Left MRM specimen; measured 19x11x3 cm, covering skin measured 19x9 cm, nipple and areola were unremarkable grossly.
- Localization: 2.5 cm lateral to the nipple
- Tumor extent
 - o Number: ill defined rubbery grayish white clipped TBS.
 - o Size: 1.5x1x1 cm.
 - o Skin involvement: 1 cm from skin
- Distance from margins: 1 cm away from deep margin
- Lymph nodes number and size: 18 lymph nodes up to 1.3x1 cm.
- Additional pathologic findings: N/A
- Immunohistochemistry technique: N/A
- Frozen section: N/A.

Microscopic examination:

- Histological type: Pathologic complete response in previously diagnosed duct carcinoma, No viable tumor cells
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): N/A
- Lymph node involvement: Free axillary lymph nodes (0/18)
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: Pathologic complete response
- Additional pathologic findings: Free nipple and areola

Diagnosis:

Verified by :
walaa ghoniem

Patient Name	: الأستاذة / حميدة سيد عبدالباسط موسى	Request No.	: 13003670
Patient No.	: 26806262800205	Request Date	: 12/01/2023
Path No.	: 110/2023	Verification Date	: 24/01/2023
Sex	: Female	Financial Category	: نفقة الدولة - Out Patient
Age	: 54 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Left breast cancer, post chemotherapy; Left MRM specimen:

- Pathologic complete response in previously diagnosed duct carcinoma, with no residual viable tumor cells.
- Free nipple and areola
- Free surgical margins
- Free axillary lymph nodes (0/18)
- Pathologic complete response
- Stage= ypT0 ypN0

Prof.Dr. Eman Gouda
Dr. Heba Mostafa

Verified by :
walea ghoniem

Printing Date : 24/01/2023 13:46:57

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

Request No. : 13002661
Request Date : 09/01/2023
Verification Date : 15/01/2023
Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Right intermediate lymph nodes

Nature of the specimen:

Tru cut biopsy collected 7-1-2023 (1:20 PM)
Gross Examination:

Gross Examination:

Multiple greyish white and fatty tissue cores up to 0.4 cm . Totally submitted .

Microscopic examination:

Histopathological examination of sections prepared from the lymph node biopsy received reveals cores of preserved normal nodal architecture. The subcapsular sinuses are patent. The lymph follicles are hyperactive and have prominent germinal centers with atypical

The lymph follicles are hyperactive and have prominent germinal centers, with dilated sinusoids. There is no evidence of specific granuloma or neoplasia in sections examined.

Diagnosis:

Right intermediate lymph nodes, Tru cut biopsy:
 • Consist with reactive lymphoid tissue.

- Consist with reactive hyperplasia
- No malignancy

Prof.Dr.Iman Gouda
Dr.Hebatallah mostafa

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 24/01/2023 11:13:31

Page 1 of 1

Printing By : .marwa mohamed youss



Patient Name : الأستاذة / حميدة سيد عبدالباسط موسى
Patient No. : 26806262800205
Path No. : SR-540/22
Sex : Female
Age : 54 Y
Referring Doc :

Request No. : 13001212
Request Date : 31/07/2022
Verification Date : 15/08/2022
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data:

Left breast mass & suspicious axillary lymph nodes

Nature of the specimen:

Slide revision

Gross Examination:

1 block (5579/22) + 1 block (6109/22) + 3 slides

Microscopic examination:

1- Breast:

* Histological type: DCIS with foci of Invasive duct carcinoma
* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II
* Angioinvasion: Positive

2-Lymph node

* Histological type: Metastatic adenocarcinoma of primary mammary ductal origin
* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): G II
(3+2+1)

-IPT:

ER: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)

PR: Weak nuclear reaction in 30% of tumor cells (Allred score 4/8)

Her-2: strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)

Diagnosis:

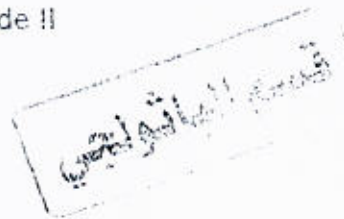
Left breast mass & suspicious axillary lymph node , slide revision :

1-Breast:

-DCIS with foci of Invasive duct carcinoma , grade II

2-Axillary Lymph nodes:

Verified by :
dr.esraa magdy



Printing Date : 15/08/2022 12:59:41

Page 1 of 2

Printing By : dr.esraa magdy



Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 21/01/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 56 Year(s)
Medical ID: 2923/2022	Pat. ID: 22983

**DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY
ULTRASOUND**

Indication:

follow-up after Left MRM

Report:

- Left MRM:
 - Operative bed shows no mass or collection
 - No regional lymphadenopathy.
- Right Breast:
 - Predominant Fatty parenchyma (ACR A)
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left MRM status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal sonomammography of right breast (BIRADS 1)

Best regards,
Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University
21/01/2025 12:05 PM



Name : Mrs. Hameeda Sayed Abd El-Basat Mousa

Date : 21/08/2022

Code : R2751741

^{18}F FDG Whole Body PET/CT

Clinical Data:

- Female with newly diagnosed breast lump

Aim of the Study:

- Metastatic work-up.

Technique:

- Whole body ^{18}F -FDG images from skull to mid thighs with the arms extending above the head were obtained.
- CT was acquired for the purpose of anatomic localization and attenuation correction. IV contrast was administered.
- Data was processed and displayed according to departmental protocol.

Review of PET, CT and fused images revealed:

Head and Neck:-

- The brain appears normal on CT, with no abnormal focal metabolic activity detected.
- Few prominent submandibular and deep cervical lymph nodes, the largest reaching about 1.3 cm seen at the left submandibular group.
- Large metabolically active left thyroid lobe well defined isodense enhancing nodule, measuring about 2x1.8 cm with SUV max 10. Smaller ill defined INACTIVE nodules are seen within the right lobe and isthmus, for further US correlation.

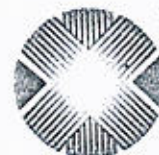


- Physiologic radiotracer uptake is demonstrated at the oropharynx, larynx, thyroid and salivary glands.
- Normal FDG uptake pattern is seen at the soft tissues of the neck.

Chest:

- Dense fibroglandular texture of the left breast, showing ill defined speculated lesion associated with tiny calcific focus is seen within the outer lower quadrant of the left breast roughly measuring about 3x1.5 cm. It shows LOW

Imaging report



CAIRO SCAN
Radiology & LRS

Name : Mrs. Hameeda Sayed Abd El-Basat Mousa
Date : 21/08/2022

Code : R2751741

grade FDG uptake with SUV max 1.8. Also seen few small clustered nodular opacities seen within the lower outer quadrant inferior to the prior lesion, the largest measures about 1 cm, also noted.



- Enlarged left axillary lymph nodes, the largest reaching about 3x1.3 cm with Mild FDG uptake and SUV max 3.3



- Solitary pulmonary nodule is seen at the medial segment of the middle lobe measuring about 8 mm
- No pleural or pericardial collections.
- Enlarged aortopulmonary lymph node, measuring about 12 mm, otherwise No metabolically active or pathologically enlarged axillary, supra-clavicular, hilar or mediastinal lymph nodes could be detected.
- Normal tracer biodistribution is noted at the myocardium and great vessels.

Abdomen and Pelvis:

- Liver is of average size, showing homogenous texture and smooth outline.
- No hepatic focal lesions or areas of abnormal enhancement or metabolic activity.
- No biliary radicles dilatations could be noted.
- Large GB stones
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, adrenals, both kidneys, aorta and IVC as well as pelvic organs
- Normal FDG activity is seen at the gastrointestinal and genitourinary systems, with no striking focal hypermetabolic lesions detected.
- No pathologically enlarged or metabolically active abdominal or pelvic lymph nodes.

Imaging report



CAIRO SCAN
Imaging & Lab

Name : Mrs. Hameeda Sayed Abd El-Basat Mousa

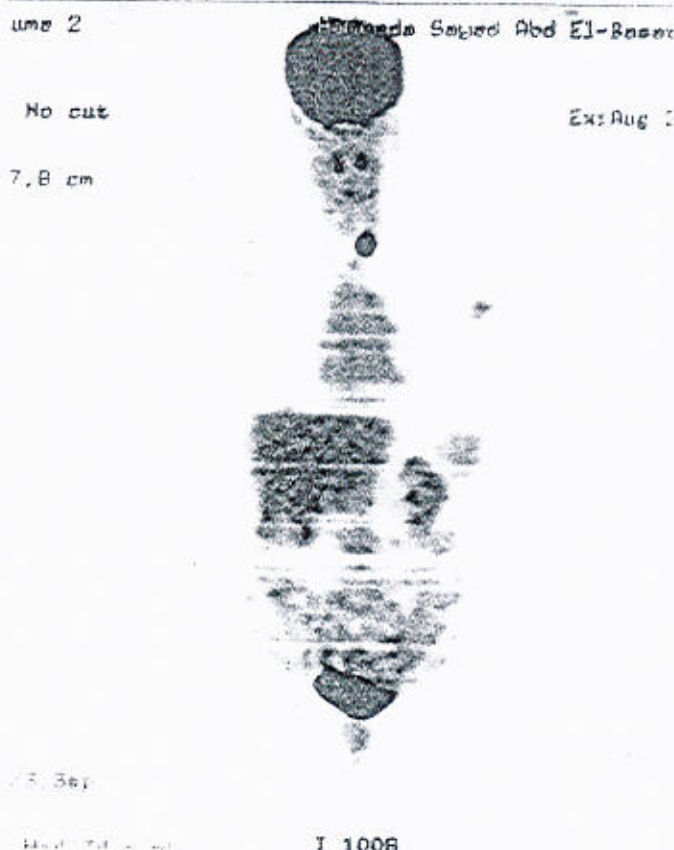
Date : 21/08/2022

Code : R2751741

- No ascites.

Musculo-skeletal:

- FDG biodistribution is rather physiologic, with no significant FDG avid blastic or lytic skeletal lesions could be detected.



OPINION :

Left breast nodule(s) with very LOW grade metabolic activity for further correlation with mammography and histopathology.

FDG avid left axillary LNs likely metastatic.

FDG avid left thyroid lobe nodule for FNAC to exclude malignancy that is highly suggested.

BEST REGARDS;

DR. AHMED ZAHER , M.D. **PROF.HAMED EL-GHAWABY**
PROF. OF NUCLEAR MEDICINE , NCI ,
CAIRO UNIVERSITY

For any inquiries regarding the findings in the report please contact us on

radreport@cairoscan.com.eg



Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 10/01/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 54 Year(s)
Medical ID:	

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

**** known case of breast cancer:**

Findings:

- Bilateral few pulmonary nodules the largest is noted in the lower left lung lobe measuring about 10 mm.
- Bilateral basal and lingular atelectatic bands associated with bilateral basal sub pleural reticulations.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- No sizable osseous lytic or sclerotic lesions in the scanned skeleton.
- Upper abdominal cuts show Calcular gallbladder.
- Enlarged thyroid gland, for dedicated US study.

OPINION:

- ***Bilateral few pulmonary nodules of indeterminate nature for follow up.***



مبادرة رئيس الجمهورية
لحماية صحة المرأة المصرية

الوزارة
القاهرة
مصر

MDT FORM

24721 / 2023 G B

Name	عبدالله محمد	MRN	6789 54321
Age	54	ID	CC - 54
Menopausal status		Phone	1155 91705
NRS SCORE		Marital status	1.98 19/19
BMI		Family history	
CO morbidity	Post NACT	REASON OF MDT	Post 1 + MRM

Clinical Data

BX: IDC: Margins: free			
LN: 0/18 - NAC: free			
ER: 0/3	PR: 2/8	HER 2: +3	Ki67: -
Sonomammography:			
Mets Workup: PET CT → free			

R Pathological Complete Response



pT0N0M0

Signature
C.C. / 1/18

Recommendations: patient Ease + post NACT
- Post MRM
- Previous It axillary LN removed with multi-contrast disc
STEP → MRM → CR for MDT

MDT OUTCOME & PLAN

for PORT / Compl
/ N waxex

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
SP 7/12/23		7/14/23			

Signature



مركز التحقيق الجنائي
بمطابق تحقيق المدعى

حميده

سيد عبد الباسط موسى

الرمادي قبلي - ابو صديق

مركز الفو - اسوان

١٩٦٨/٠٩

٢٦٨٠٦٢٦٢٨٠٠٢٠٥

LY2794276



٢٠٢٦/٠٩

٢٦٨٠٦٢٦٢٨٠٠٢٠٥

ريه منزل

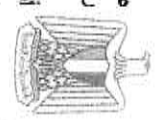
مقروجة

مسلمة

انثى

محمد صالح محمد حسين

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٨/٣١



HEALTH INSURANCE

UHIA

إدارة خدمة العملاء



عاملة للتأمين الصحي الشامل
فرع أسوان
؛ العامة لشئون المستفيدين

736	رقم مسلسل
مستشفى جوستاف روسي الدولي - أوراام دار السلام هرميل	السيد الدكتور / مدير
حميدة سيد عبدالباسط موسى	قادم لسبب انكم السيد /
الرمادي قبلي - ابو صديق مركز القفر	العنوان
ربه منزل	جهة العمل
25806122800139	الرقم القومي لعائل الأسرة
26806262800205	الرقم القومي لطالب الخدمة
01120709869	رقم هاتف التواصل
58 أعوام / أنثى	السن / النوع
2640	رقم التأمين الصحي
وحدة الفوالية	الوحدة التابع لها
غير معروف	طبيب الأسرة
غير معروف	الطبيب / مصدر التقرير الطبي
ورم خبيث بالثدي	تشخيص
مزمن	نوع التشخيص : مزمن / غير مزمن
تحتاج إلى استكمال العلاج الهيرموني (تاموفين) والعلاج التجمعي مع عمل الفحوصات والاشعاعات والتحليل اللازمه لمدة 3 اشهر من تاريخ اصدار الخطابي مع الاقرارام بتنفيذ الاجراءات ذات صلة بالبروتوكول	الخدمة المطلوبة ؟
-	تاريخ الدخول
-	تاريخ الخروج
لا	هل تحتاج لموافقة مسبقة ؟
لا	هل تحتاج لموافقة استثنائية ؟
طبقا لأسعار المحافظة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فرع أسوان	سعر الخدمة

تم تحصيل المساهمة بإصدار رقم (بتاريخ)
بوجه قبول الحالة وذلك على حساب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فرع أسوان

مع الاقرارام بتنفيذ الاجراءات ذات صلة بالبروتوكول

مدير الإدارة العامة لشئون المستفيدين/
مدير إدارة خدمة العملاء

الطبيب المراجع

الموظف المختص

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

الاسم / احمد مدحت عبد المطلب
التوقيع /

ختم الإدارة

تحرير افي : 2026-09-15

يرفق رقم الحساب للأمداد / رقم تلفون للتواصل

الخطابي صالح لمدة (14) أربعة عشر يوما من تاريخه يرفق رقم الحساب للأمداد / رقم تلفون للتواصل
يرفق عند تقديم المطالبة نتائج التحليل والاشعاعات والتحاليل الطبية

712V

Patient Name Hamed a sayed	Date : 25/07/2026
Exam : Ultrasound ABDOMEN& PELVIS	

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver:-

- AVERAGE SIZED 14CMat Rt MCL)homogenous parenchymal echo pattern
- No IHBRD seen
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder:-

Contracted and cannot be properly visualised
CBD normal

Spleen:-

- Normal size 9 cm, homogenous texture with no focal lesions

Kidneys:-

- Both kidneys of normal size, shape, normal echogenicity and well differentiated with good corticomedullary differentiation.
- No stones , no back pressure changes

Para-aortic and pancreatic area: concealed by gaseous distention

Urinary Bladder:-

- Minimally Filled with no stones or masses

Opinion:

Unremarkable study

Patient's Name:

Hamida Said Abdelbasel Mousa

Date:

2026-07-25

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt



Right Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post left MRM , routine follow up.

Findings:

Right breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections.
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.
-

Conclusion:-

- *Right breast (BIRADS 1): normal study.*
- *Clear left mastectomy bed and axilla.*

Recommendation:-

- *For annual follow up.*

Best Regards,

DR. Marwa M.Hassan

٢٩٢٢
٢٠٢٢

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



حميدة
سميرة عبدالباسط موسى
الرمادي قبلي - ابوصديق
مركز ادفو - اسوان

٢ ٦٨ ٠ ٦ ٢٦ ٢٨ ٠ ٠ ٢ ٠ ٥

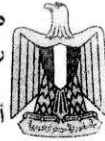
IB2169115





٢٠١٩/٠٧ ٢٦٨ ٢٢٦٢٨٠٠٠٢٠٥

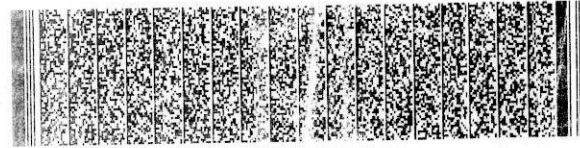
ربة منزل



أنثى مسلمة متزوجة
محمد صالح محمد حسين

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٠٧/١٥

٤





83086292 MDT FORM 23 / 8 / 2022 G

Name	حميدة سيد عبدالباسم	MRN	٢٠٢٢ - ٢٩ ٢٣
		ID	٢٦٨٠٦٢٦٢٨٠٠٠٠
Age	54	Phone	١١٤٤٩٧١٦٢
Menopausal status	perimenopausal	marital status	Married
NRS SCORE	one	Family history	-ve
BMI	24 → Normal	REASON OF MDT	-
Co morbidity	D - HTN		

Clinical Data

Bx:	IDC II			R	L
ER:	0/8	PR:	3/8	HER 2:	+ve
				Ki67:	
Submammography: ① Mamma 3 o'clock 1,5 ② Mass					
Mets Workup: CTs → iliac bone / Lung ?? bone lesion, Thyroid Bone → Indeterminate PET/CT → Free				T N M	

Recommendations:

pt is not metastatic

PET -ve

MDT OUTCOME & PLAN

Pr T₁CHP 6 cycles, FNA from
Thyroid nodule → Benign Follicular (Bethesda II)

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	psychiatric

23 / 8 / 2022
Angilsh 23 / 8 / 2022



Post OP 0.2

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية
صحة
مصر

MDT FORM 24721 / 2023 G B

Name	عبد الله محمد	MRN	C7N957CA...
Age	54	ID	C.CC - C7CA
Menopausal status		Phone	115591705
NRS SCORE		Marital status	1.9919119.
BMI		Family history	
CO morbidity	Post NACT	REASON OF MDT	Post 1+MRM

Clinical Data

BX: DC: Margins: free LN: 0/18 - NAC: free			
ER: 0/3	PR: 2/8	HER 2: 43	Ki67: -
Sonomammography:			
Mets Workup: PET CT → free			

R Pathological Complete Response

pT₀N₀M₀

C.C. / 1/CE

Recommendations: patient Case to Post NACT
- Postoperative MRM
- previous axillary LN Present with multicentric disease
STEP → MRM → CR For MDT

MDT OUTCOME & PLAN

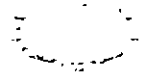
for PORT / complete
/ N/A

Yes history/psych

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
SP 7/2/2023		Amal 7/2/2023			

Amal



Patient Name : الأستاذة / حميدة سيد عبدالباسط موسى	Request No. : 13003670
Patient No. : 26806262800205	Request Date : 12/01/2023
Path No. : 110/2023	Verification Date : 24/01/2023
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 54 Y	Department : Out Patient
Referreing Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post chemotherapy.

Nature of the specimen: Left MRM specimen.

Gross Examination:

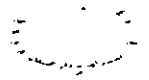
- Procedure: Left MRM specimen; measured 19x11x3 cm, covering skin measured 19x9 cm, nipple and areola were unremarkable grossly.
- Localization: 2.5 cm lateral to the nipple
- Tumor extent
 - o Number: Ill defined rubbery grayish white clipped TBS.
 - o Size: 1.5x1x1 cm.
 - o Skin involvement: 1 cm from skin
- Distance from margins: 1 cm away from deep margin
- Lymph nodes number and size: 18 lymph nodes up to 1.3x1 cm.
- Additional pathologic findings: N/A
- Immunohistochemistry technique: N/A
- Frozen section: N/A.

Microscopic examination:

- Histological type: Pathologic complete response in previously diagnosed duct carcinoma, No viable tumor cells
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): N/A
- Lymph node involvement: Free axillary lymph nodes (0/18)
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: Pathologic complete response
- Additional pathologic findings: Free nipple and areola

Diagnosis:

Verified by :
walaa ghoniem



Patient Name	: الأستاذة / حميدة سيد عبدالجاسط موسى	Request No.	: 13003670
Patient No.	: 26806262800205	Request Date	: 12/01/2023
Path No.	: 110/2023	Verification Date	: 24/01/2023
Sex	: Female	Financial Category	: نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age	: 54 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

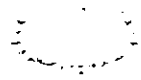
Pathology Report

Left breast cancer, post chemotherapy; Left MRM specimen:

- Pathologic complete response in previously diagnosed duct carcinoma, with no residual viable tumor cells.
- Free nipple and areola
- Free surgical margins
- Free axillary lymph nodes (0/18)
- Pathologic complete response
- Stage= ypT0 ypN0

Prof.Dr. Eman Gouda
Dr. Heba Mostafa

Verified by :
walaa ghoniem



Patient Name : الأستاذة / حميدة سيد عبدالباسط موسى	Request No. : 13002661
Patient No. : 26806262800205	Request Date : 09/01/2023
Path No. : 65/2023	Verification Date : 15/01/2023
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 54 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Right intermediate lymph nodes

Nature of the specimen:

Tru cut biopsy collected 7-1-2023 (1:20 PM)

Gross Examination:

Multiple greyish white and fatty tissue cores up to 0.4 cm . Totally submitted .

Microscopic examination:

Histopathological examination of sections prepared from the lymph node biopsy received reveals cores of preserved normal nodal architecture. The subcapsular sinuses are patent. The lymph follicles are hyperactive and have prominent germinal centers, with dilated sinoids . There is no evidence of specific granuloma or neoplasia in sections examined.

Diagnosis:

Right intermediate lymph nodes , Tru cut biopsy:

- Consist with reactive hyperplasia
- No malignancy

Prof.Dr.Iman Gouda
Dr.Hebatallah mostafa

Verified by :
dr.esraa magdy

Patient Name : الأستاذة / حميدة سيد عبدالباسط موسى	Request No. : 13001212
Patient No. : 26806262800205	Request Date : 31/07/2022
Path No. : SR-540/22	Verification Date : 15/08/2022
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 54 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Ali mostafa

Pathology Report**Clinical Data:**

Left breast mass & suspicious axillary lymph nodes

Nature of the specimen:

Slide revision

Gross Examination:

1 block (5579/22) + 1 block (6109/22) + 3 slides

Microscopic examination:**1- Breast:**

* Histological type: DCIS with foci of Invasive duct carcinoma .

* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II

*Angioinvasion: Positive

2-Lymph node:* Histological type: Metastatic adenocarcinoma of primary mammary ductal origin

* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): G II

(3+2+1)

-IPT:

ER: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)

PR: Weak nuclear reaction in 30% of tumor cells (Allred score 4/8)

Her-2: strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).

Diagnosis:

Left breast mass & suspicious axillary lymph node , slide revision :

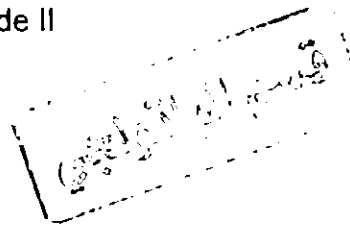
1-Breast:

-DCIS with foci of Invasive duct carcinoma , grade II

2-Axillary Lymph nodes:

Verified by :

dr.esraa magdy



Printing Date : 15/08/2022 12:59:41

Page 1 of 2

Printing By : dr.esraa magdy

	Med. Record No.:	2022195618
	Patient Name:	HAMEDA SAYED ABDELBASET MOSA
	Sex:	Female DOB: 6/26/1968
	Nationality:	EGYPTIAN
	Unit:	External Clinic

IMMUNOPATHOLOGY - Final Anatomical Diagnosis
Hormone receptors

Specimen Id	2207230370	Sample Type	Paraffin Block
Accession No	IMM22-4839	Requesting Doctor	Abd ALLAH Mohamed Gamil
Collection Date	7/23/2022 12:39:21PM		
Receive Date	7/23/2022 12:39:32PM		

Immunohistochemical Report

pathology number
6109/22

Clinical Data
LT axillary l.node metastatic carcinoma.

Gross Picture :
[Referred block submitted for ER/PR Immunostaining.]

System Used :
[Ventana BenchMark ULTRA autostainer.]

Antibody:
[Ventana anti-PR(1E2) Rabbit monoclonal antibody, Ventana anti-ER(SP1) Rabbit monoclonal antibody.]

Scoring system :
According to the ASCO/CAP guideline update, 2019 : Samples with 1% to 100% of tumor nuclei positive for ER or progesterone receptor (PgR) are interpreted as positive. If ER (not PgR), 1% to 10% of tumor cell nuclei are immunoreactive, the sample are reported as ER Low Positive. A sample is considered negative for ER or PgR if < 1% or 0% of tumor cell nuclei are immunoreactive. Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, <1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%–100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8. Comment: - There are much more limited data on the 2% to 3% of cancers that are low ER expressers (most often defined as 1%-10% ER-positive cells by IHC) and their potential benefit from endocrine therapy. - PR positive in 1-20% of tumor cells is considered as Low positive.

(Laterality) breast Cancer:
[left]

Diagnosis :
LT axillary l.node metastatic carcinoma:
ER :Negative, weak nuclear reaction in <1% of tumor cells (2/8).
PR : Low positive, weak nuclear reaction in 10% of tumor cells (3/8).

Signature
[MAHITAB IBRAHIM MOHAMED PHD]

	Med. Record No.:	2022195618
	Patient Name:	HAMEDA SAYED ABDELBASET MOSA
	Sex:	Female DOB: 6/26/1968
	Nationality:	EGYPTIAN
	Unit:	External Clinic

IMMUNOPATHOLOGY - Final Anatomical Diagnosis
Her2 Receptors

Specimen Id	2207230371	Sample Type	Paraffin Block
Accession No	IMM22-4840	Requesting Doctor	Abd ALLAH Mohamed Gamil
Collection Date	7/23/2022 12:39:28PM		
Receive Date	7/23/2022 12:39:36PM		

Immunohistochemical Report

pathology number
6109/22

Clinical Data
LT axillary l.node metastatic carcinoma.

Gross Picture :
[“Referred block submitted for HER 2 Immunostaining.”]

System Used :
[“Ventana BenchMark ULTRA autostainer.”]

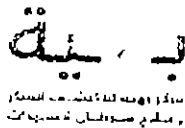
Antibody:
[“Ventana anti-HER-2 (4B5) rabbit monoclonal antibody.”]

Scoring system :
Reference: ASCO—CAP HER2 Test Guideline Recommendations, 2018. IHC 0 :as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within <=10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within >10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: The revised definition of IHC 2+ (equivocal) is weak to moderate complete membrane staining observed in >10% of tumor cells.. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense in >10 % of tumor cells.

Laterality - 1
[“Left”]

Her2 Result - 1
[“Positive [score 3+]”]

Signature
[“MAHITAB IBRAHIM MOHAMED PHD”]



Med. Record No.: 2022195618
 Patient Name: HAMEDA SAYED ABDELBASET MOSA
 Sex: Female DOB: 6/26/1968
 Nationality: EGYPTIAN
 Unit: Oncology Surgery

SURGICAL PATHOLOGY - Final Anatomical Diagnosis

Biopsy Small - (1 Site)

Specimen Id	2206260503	Sample Type	Tissue
Accession No	SUR22-5579	Requesting Doctor	Ibrahim Adel Mohamed Shaker
Collection Date	6/26/2022 6:55:51PM		
Receive Date	6/26/2022 6:55:57PM		

Clinical Information

Left breast 3:00 highly suspicious lesion (BIRADS 5), with pathologic axillary l. node

Gross Picture

Multiplo cores 0.7-1.2 cm, totally embedded.

Microscopic Picture

A case of ductal carcinoma insitu (solid pattern), high grade. Stroma is desmoplastic with dense lymphoid infiltrate. There are two foci stromal microinvasion (1mm) in the current material.

Diagnostic Summary

Tumour type:

Ductal carcinoma insitu, high grade with foci of stromal microinvasion

Laterality

["Left"]

Specimen type:

U/S guided Tru-cut biopsy.

Diagnosis

Left breast, Tru-cut biopsy:

Ductal carcinoma insitu, high grade with foci of stromal microinvasion.

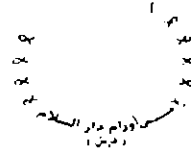
N.B: Tissue biopsy from the described pathologic l. node is recommended to assess invasiveness and HER2 status assessment.

Signature

["Heba Abdallah"]

Co-signed by:

["Dr. Ghada M. Abdelsalam, MD"]



Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 13/12/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 55 Year(s)
Medical ID: 2923/2022	Pat. ID: 22983

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM.

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

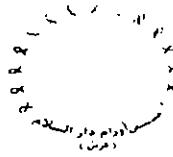
- scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Signature Dr. Nehal Hamdy

13/12/2023 11:07 AM



Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 13/12/2023
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 55 Year(s)
Medical ID: 2923/2022	Pat. ID: 22983

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- *Enlarged in size (16.8cm at Rt MCL) bright parenchymal echopattern with smooth surface.*
- *No hepatic focal lesions or intra hepatic billiary radicle dilatation.*
- *Portal vein is patent and not dilated.*

Gall Bladder: -

- *Average distention and capacity with multiple large stones seen inside*
- *The wall is not thickened.*
- *CBD is not dilated.*

Spleen: -

Average size , homogenous.

Kidneys: -

- *Both are average in size,shape and echogenicity*
- *No stones or dilated pelvicalyceal system*
- *No gross lesion*

Para-aortic and pancreatic area: *show no gross abnormalities.*

No ascites

Urinary Bladder: -

empty

Opinion:

*Bright hepatomegaly likely fatty
Calcular GB*

Signature Dr . Nermien Ramadan
PM 12:31 2023/12/13



٢٩٢٢

٢٢

حبيبه / Echo report

Name:

Date: 13/4/2023

EF	63%	55-75%	PWT		0.6-1.1cm
LVEDD	5.1	3.5-5.8cm	AO.R	3.1	2-3.7cm
LVESD	3.4	2-4cm	LA	3.2	2-4cm
FS	34%	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions

LV wall thickness

LV diastolic function DDGI

SWMA No RWMA at rest

LA and Aortic root dimensions

Mitral Valve

Aortic valve

Tricuspid valve

Pulmonary valve

Right side and systolic function

Intracardiac masses and effusion No

D/ Mohamed Ali

Msc cardiology

PATIENT NAME: HAMEDA SAYED ABDELBASET MOSA	PATIENT ID #: 2022195618
GENDER: Female	ORDER #: 1694319,1695542
AGE: 54 y	DATE OF SERVICE: 26-Jun-2022 02:22 PM

26/6

Clinical indication - all studies

Left breast highly suspicious mass

Report: - all studies

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY

TECHNIQUE:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO view.
- Targeted ultrasound

REPORT:

- Both breasts show heterogeneous fibroglandular densities (ACR c).

LEFT BREAST:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed moderate background parenchymal enhancement with heterogeneously enhancing lesions are seen nearly at 3:00, the largest measuring about 2.7x1.2cm in diameter, targeted Ultrasound revealed corresponding two micro-lobulated lesions at 3:00, measuring about 2x0.8cm and 1x0.5cm in diameter respectively.
- Small faint enhancing nodules are noted 9:00 and 12:00, targeted ultrasound revealed corresponding small indistinct hypoechoic nodule located at 9:00, measuring about 5x4mm in diameter.

RIGHT BREAST:

- No spiculated mass lesions or microcalcific clusters.
- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed moderate background parenchymal enhancement with no significant enhancing lesions.
- Normal nipple areola complexes.

OPINION:

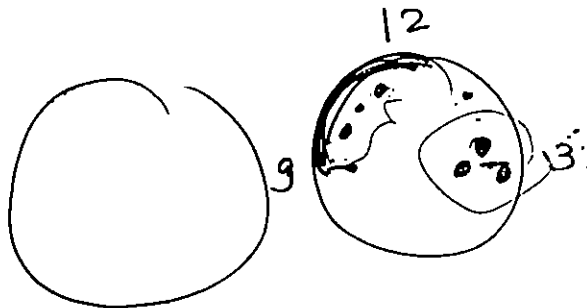
- Left breast 3:00 highly suspicious lesions along with 9:00 and 12:00 suspicious enhancing nodules suggesting multicentric malignant process (BIRADS 5).
- No right breast pathological enhancement (BIRADS 2).

Recommendation - all studies

Reported By,

Dr Lobna KHALED.MD

26-Jun-2022 03:54 PM





Echo report

Name:

Date : 1 / 1 / 2023

MR ٢٢ / ٢٩٢٢

EF	61.1	55-75%	PWT	0.9	0.6-1.1cm
LVEDD	4.4	3.5-5.8cm	AO.R	2.3	2-3.7cm
LVESD	2.9	2-4cm	LA	3.1	2-4cm
FS	32	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

— systolic function with — internal dimension EF 61%
imp diastolic function. grade I.

— LA and Ao root dimensions.

— Mitral Valve morphology

No resting SWMA.

— Aortic valve morphology

— Tricuspid valve morphology and leaflets

Normal Pulmonary Valve.

No intrcardiac masses or pericardial effusion

Conclulsion: Diastolic dyf grade I.

—

Dr. Mohamed A. Wahab

Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 10/11/2022
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 54 Year(s)
Medical ID: 2923/2022	

**DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND
COMPLEMENTARY ULTRASOUND**

Indication:

Post NACT status assessment of a known left breast malignant mass

Report:

- ACR b: scattered fibro-glandular parenchyma of both breasts
- Left breast:
 - UOQ faint grouped microcalcifications with clip is seen inserted insitu. Ultrasound shows no underlying definite lesions.
 - Left axillary (level I and II) pathological lymph nodes are still seen.
 - No supraclavicular lymph nodes.
- Right breast:
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - **Indeterminate right enlarged axillary LN with uniform increase of cortical thickness reaching about 4.3 mm.**

Opinion:

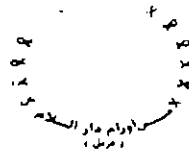
- Post NACT status of left breast showing complete radiological response of the previously noted malignant mass with pathological level I and II axillary lymphadenopathy (BIRADS 6)
- Right indeterminate axillary lymph nodes.
- Normal sonomammography of right breast (BIRADS 1)

Best regards,

Dr/Asmaa Zeinhom, Msc

Signature Temp

10/11/2022 2:00 PM



Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 21/01/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 56 Year(s)
Medical ID: 2923/2022	Pat. ID: 22983

**DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY
ULTRASOUND**

Indication:

follow-up after Left MRM

Report:

- Left MRM:
 - Operative bed shows no mass or collection
 - No regional lymphadenopathy.
- Right Breast:
 - Predominant Fatty parenchyma (ACR A)
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left MRM status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal sonomammography of right breast (BIRADS 1)

Best regards,
Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University
21/01/2025 12:05 PM

PATIENT NAME: HAMEDA SAYED ABDELBASET MOSA	PATIENT ID #: 2022195618
GENDER: Female	ORDER #: 1744752,1744753
AGE: 54 y	DATE OF SERVICE: 26-Jul-2022 03:07 PM

Report: - all studies

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS**

1- CHEST:

- Left breast UOQ irregular spiculated mass lesion measuring 20 X 13 mm.
- Enlarged left axillary level I and II lymph nodes the largest measures 32 X 13 mm.
- Few bilateral pulmonary nodules the largest is seen at medial segment of middle lung lobe measuring 9 mm.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormalities. No pericardial effusion detected.
- Left thyroid hypodense nodule.

2- ABDOMEN AND PELVIS

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Calcular gall bladder.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenal glands.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.



Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 10/01/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 54 Year(s)
Medical ID:	

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

**** known case of breast cancer:**

Findings:

- Bilateral few pulmonary nodules the largest is noted in the lower left lung lobe measuring about 10 mm.
- Bilateral basal and lingular atelectatic bands associated with bilateral basal sub pleural reticulations.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- No sizable osseous lytic or sclerotic lesions in the scanned skeleton.
- Upper abdominal cuts show Calcular gallbladder.
- Enlarged thyroid gland, for dedicated US study.

OPINION:

- ***Bilateral few pulmonary nodules of indeterminate nature for follow up.***



Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 10/01/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 54 Year(s)
Medical ID:	

- ***Bilateral basal and lingular atelectatic bands associated with bilateral basal sub pleural reticulations , likely post inflammatory sequel.***
- ***Calcular gallbladder.***

Dr. Mohammed Mahjoub

Dr. *M. Gomaa*, M.D.



٢٩٢٢

٢٢

وزارة الصحة والسكان
امانة المستشفى الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام

حسينه / محمد عبد الباقى
Echo report

Name:

Date: 7/4/2023

EF	63%	55-75%	PWT		0.6-1.1cm
LVEDD	5.1	3.5-5.8cm	AO.R	3.1	2-3.7cm
LVESD	3.4	2-4cm	LA	3.2	2-4cm
FS	34%	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions

LV wall thickness

LV diastolic function ~~DD~~ GI

SWMA No RWMA at rest

LA and Aortic root dimensions

Mitral Valve

Aortic valve

Tricuspid valve

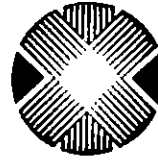
Pulmonary valve

Right side and systolic function

Intracardiac masses and effusion No

D/ Mohamed Ali

Msc cardiology



Imaging report

Name : Mrs. Hameeda Sayed Abd El-Basat Mousa

Date : 21/08/2022

Code : R2751741

^{18}F FDG Whole Body PET/CT

Clinical Data:

- Female with newly diagnosed breast lump

Aim of the Study:

- Metastatic work-up.

Technique:

- Whole body ^{18}F -FDG images from skull to mid thighs with the arms extending above the head were obtained.
- CT was acquired for the purpose of anatomic localization and attenuation correction. IV contrast was administered.
- Data was processed and displayed according to departmental protocol.

Review of PET, CT and fused images revealed:

Head and Neck:-

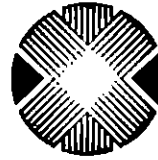
- The brain appears normal on CT, with no abnormal focal metabolic activity detected.
- Few prominent submandibular and deep cervical lymph nodes, the largest reaching about 1.3 cm seen at the left submandibular group.
- Large metabolically active left thyroid lobe well defined isodense enhancing nodule, measuring about 2x1.8 cm with SUV max 10. Smaller ill defined INACTIVE nodules are seen within the right lobe and isthmus, for further US correlation.



- Physiologic radiotracer uptake is demonstrated at the oropharynx, larynx, thyroid and salivary glands.
- Normal FDG uptake pattern is seen at the soft tissues of the neck.

Chest:

- Dense fibroglandular texture of the left breast, showing ill defined speculated lesion associated with tiny calcific focus is seen within the outer lower quadrant of the left breast roughly measuring about 3x1.5 cm. It shows LOW



Imaging report

Name : Mrs. Hameeda Sayed Abd El-Basat Mousa

Date : 21/08/2022

Code : R2751741

grade FDG uptake with SUV max 1.8. Also seen few small clustered nodular opacities seen within the lower outer quadrant inferior to the prior lesion, the largest measures about 1 cm, also noted.



- Enlarged left axillary lymph nodes, the largest reaching about 3x1.3 cm with Mild FDG uptake and SUV max 3.3



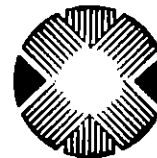
- Solitary pulmonary nodule is seen at the medial segment of the middle lobe measuring about 8 mm
- No pleural or pericardial collections.
- Enlarged aortopulmonary lymph node, measuring about 12 mm, otherwise No metabolically active or pathologically enlarged axillary, supra-clavicular, hilar or mediastinal lymph nodes could be detected.
- Normal tracer biodistribution is noted at the myocardium and great vessels.

Abdomen and Pelvis:

- Liver is of average size, showing homogenous texture and smooth outline.
- No hepatic focal lesions or areas of abnormal enhancement or metabolic activity.
- No biliary radicles dilatations could be noted.
- Large GB stones
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, adrenals, both kidneys, aorta and IVC as well as pelvic organs
- Normal FDG activity is seen at the gastrointestinal and genitourinary systems, with no striking focal hypermetabolic lesions detected.
- No pathologically enlarged or metabolically active abdominal or pelvic lymph nodes.



Imaging report



كايرو سكات
للأشعة والتخيل
CAIRO SCAN
Radiology & IAS

Name : Mrs. Hameeda Sayed Abd El-Basat Mousa

Date : 21/08/2022

Code : R2751741

- No ascites.

Musculo-skeletal:

- FDG biodistribution is rather physiologic, with no significant FDG avid blastic or lytic skeletal lesions could be detected.

une 2

Hameeda Sayed Abd El-Basat

No cut

Ext Aug 2

7.8 cm

/3.3ep

M-1 7.8 1.21

I 1008

OPINION :

Left breast nodule(s) with very LOW grade metabolic activity for further correlation with mammography and histopathology.

FDG avid left axillary LNs likely metastatic.

FDG avid left thyroid lobe nodule for FNAC to exclude malignancy that is highly suggested.

BEST REGARDS;

DR. AHMED ZAHER , M.D. PROF.HAMED EL-GHAWABY
PROF. OF NUCLEAR MEDICINE , NCI ,
CAIRO UNIVERSITY

For any inquiries regarding the findings in the report please contact us on

radreport@cairoscan.com.eg



119

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام

حميدة

اسم المريض رباعي :
رقم الملف الطبي :
نوع الوجبة :
تاريخ اعداد الوجبة :
وقت اعداد الوجبة :

port

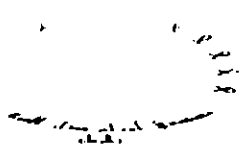
وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام

EF	62	55-75%	PWT	0.8	0.6-1.1cm
LVEDL	5.4	3.5-5.8cm	AO.R	3.1	2-3.7cm
LVESL	3.6	2-4cm	LA	3.5	2-4cm
FS	34	25-45%	RV	normal	0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.8	0.6-1.1cm	AO.CUSP	normal	1.5-2.6cm

LV dimensions *normal*LV wall thickness *normal*LV diastolic function *6 I D D.*SWMA *normal*LA and Aortic root dimensions *normal*Mitral Valve *thicker e' Trivial MR*Aortic valve: *normal*Tricuspid valve *normal e' Trivial TR, normal RVIP.*Pulmonary valve *normal*Right side and systolic function *normal*Intracardiac masses and effusion *normal*

D mohammed Anwar

Msc cardiology



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

Patient ID:

Name : حميدة سيد عبدالمجيد موسى

Sex:

3- Medical number:

Female

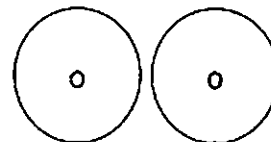
83086292

Old Med :

2923/2022

ID number: 26806262800205

Patient Age : 55 Y



Family history

-VE

Phone

01099198190

BMI

wt = 68 kg

ht = 160 cm

REASON OF MDT

POST NACT

marital status

NRS Score

1

GROUP

BMI = 26

Date of MDT

01/07/2023

Co morbidity

DM ON OHGS,,

marital status

MARRIED

Menopausal status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

PETCT-->FREE

BX:

LT IDC GII WITH
DCIS WITH FOCI
8/22

IHC:

ER:

0/8

PR:

4/8

Her 2 Neu :

+VE

KI67 :

T

N

M

Sonomammography

CESM--> LT BREAST MASS AT 3 O'CLOCK 2.7X1.2+ 2 MICRO LOBULATED LESIONS 2X.8CM
1X.5 CM

Recommendations:

THE CONDITION STARTED IN 2022 BY LT AXILLARY LN ACCIDENTALLY DISCOVERED
SHE ENDED NACT TCX18 WKS LAST ONE ON 22/12/2022,,,HP X6 LAST ONE ON 29/12/22

MDT OUTCOME & PLAN

FOR LT MRM (multicentric&ycN1) after FNAC of contra-lateral indeterminate axilla

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	



WT 65
HT 155
SA 167

Age: 54
ABW: 54.7
Scr: 0.8
CrCl: 69.4

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
هرمل، سابقا
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

EF 65-J- on 16/8

اسم المريض

الرقم الطبي

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

* C10: - Epigastric pain.
- Mild Nausea.
- Baseline Bilat. LL Neuropathy, G.I
"Diabetic"

* For: C/w2 Taxol 123mg
Carbo. AUC (2) Today Carbo: 189mg
apn Hader 1/9

- C/w3 Taxol 123mg
Carbo. AUC (2) on 8/9/2022 Carbo: 189
apn Hader 8/9

- H/P is still pending.

- FNA from Thyroid nodule is done. Pending results.

توقيع الطبيب: د. كاترينة
Controloc 40mg 1x1/4 days.
Oraldene 28mg Patch 4x7 days.
التاريخ: 19/11
الوقت:

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

C/w2 Taxol/Carbo.
C1 H/P
cl.ph
15/9/2022

Cr: 0.8 Carbo: 173mg

C/w2 TC [173mg]
C1.ph Hader
22/9/2022
التاريخ:
الوقت:

توقيع الطبيب:

الوقت:

C.C. 19/11

C.C. 19/11

C.C. 19/11

2923 | 22

.....: نوع التغذية

.....:التشخيص:

صلى الله عليه وآله وسلم

يُعي الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

.....: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
13/10/2022		A * C.I.O.: - G.H. Diarrhea, G.H. Nausea, vomiting. - No ↑ in Baseline Bilat. LL Neuropathy G.I.	
		* MRI Pelvis [9/10/2022]: Normal	
		* Fec: - C ₃ w ₂ Taxol 125mg Carbo AUC: [2]	Today
		- C ₃ w ₃ Taxol 125mg Carbo AUC: [2] ✓ on	20/10/2022 <u>C3w3</u>
		- Control ec 40mg Tab. 1x1x 14 days - Em-Ex Tab. 1x2x 10 days - Hydrocort Tab. 1x2x 10 days	PH/AHMED MAHER C3W3 TC 13/10/2022
			د. كاترين ع.ع. 1.1 / 13
			C3W3 TC 28mg Nile 20/10/22

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



Age 54 yrs

wt 65

Ht 155

S.A1.67

ABW 54.7

S.Cv.04 → 0.7

crcl 79.33

Canula site (208)

وزارة الصحة و السكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اور ددر السلام "نرمز"

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :

الرقم الطبي :

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

زوداً ارم + ارم + ارم + ارم + ارم
تحويل (10) مع 1000
كاربونيل 200
برم 100
هرم 100
خارج زرع 100
توقيع الطبيب سراج
الحمد يوم 10/11/2022

C.Ph/Aya Diau

27/10/2022

(TCHP)

التاريخ:
الوقت:

wt 65
(208 mg)

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

C.CC 10/10

Arden

اسبوعين

C.Ph/Aya Diau

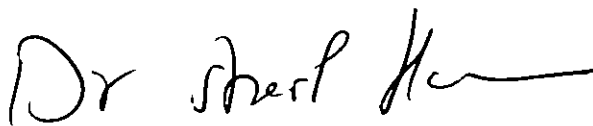
3/11/2022

wt 65
C.CC (208 mg)
C.C

التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب :



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجردة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

10/11/22

اسم المريض :

الرقم الطبي :

Carbamide الأوامر AUC 2

chest:

Group:

Oral mucositis:

Canula site infection

Conteúdo em L=)

Country Loss

News at 1X2

Intand Eco Lr

توقيع الطبيب :

التاريخ: 15/3
الوقت: 10:30

Mounta Lv 2
الأوامر

الأوامر

chest:

Temp:

~~Cutal prucosifis:~~

Canula site infection

Land gr 123 $\frac{67}{11}$ / 5

Cataphor Lvl

MM pd
free

W2 TC (209-9)

Clph Henderson
10/11

توقيع الطبيب :

التاريخ:

الوقت:



Age 54

wt 65

Ht 155

BSA 1.6

→ ABWL SL 17

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام

(شمل سابقاً)

إدارة الموردة

??

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :

الرقم الطبي :

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

Disappe h Breast mas
4 still felt axillary LN.

w/6 Taxol 4 Carbop 4 Hap CS

w/6 R/Taxol 12s → 500mL / 4h

R/Carbop 400mg

R/Horaph 600mg CS Phes 90

R/Herceptin 4200mg IV

R/Emax 1x 2 RSDay

R/Emax 2 4x 2 RSDay

R/Newton 1x 130

Canula site infection:

w/6 Taxol 4 Carbop 4 Hap CS

10/10

w/6 TC (209)

14/12

2022

التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب:



وزارة الصحة والسكان
إمارة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :

الرقم الطبي :

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

22/12/2022

for W18 TC

+ MDT

توقيع الطبيب : د. محمد بن محمد

التاريخ: / /

الوقت:

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

29/12/2022

for C6 H/p.

12
توقيع الطبيب : د. محمد بن محمد

التاريخ: / /

الوقت:



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام (هرمل)
الصيدلة الإكلينيكية

[MBC] >> Paclitaxel/Carboplatin AUC 5 + Trastuzumab
Protocol Cycle (.....)

اليوم: التاريخ: 2022/12/22		المرضى: اسم المريض: محمد عبد الله	
رقم الملف:		TC 18 W 22/12	
Weight: kg	Height: cm	BSA: M2	Age: years
CBC:	WBC: ANC: Hgb: PLT:		
Functions Tests:	Sr.Creat: Urea: CrCL:		
	ALT: AST: T.Bil: D.Bil:		
Echo:	Date: 8/12	EF: 66% (circled)	
Dose Modification: %			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
الصرف	بروتوكول العلاج		
19/12	جرانيسيترون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 20 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيماوي. (Maximum dose of Granisetron = 1mg)		
19/12	تراستوزوماب علي 250 مل ملح لمدة نصف ساعة (علي 500 مل ملح لمدة ساعة ونصف الجرعة الاولى فقط) Loading Dose: 8 mg/m ² Maintenance Dose: 6 mg/m ² (MAX: 440 mg) next week		
19/12	باكليتاكسل (175 مجم/م ²) مجم في 500 مل ج 5% علي مدي ساعة		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
19/12	كاربوبلاتين (AUC 2) مجم في 500 مل ج 5% علي ساعة.		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
العلاج التدايمي:			
كونترولوك قرص 40 مجم علي الريق لمدة اسبوع. C X X X ديكساميثازون 8 مجم (امبول او قرص) كل 12 ساعة لمدة 3 ايام تبدأ اليوم السابق للجرعة. ايمند قرص 125 مجم اليوم الاول و 80 مجم اليوم الثاني و الثالث. - شيرفيت 3 X X X - يا رامول 2 X X X - حوتيلون 7 X X X - فيسر الجسيم 7 X X X			
Physician Signature:	Clinical pharmacy:	Dispensing pharmacy:	
د 18	Ph/Aya Ncum 22/12/2022	T.C (208)	



Phage 2

\ \

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
اورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

Dr. L. A.

اسم المريض :

الرقم الطبى :

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection

page 420 any

Heptan be any

فرمان

C. 41 1/6

2/15

CC-116/20

Dehter

التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب :

C₆H₆

Cl. ph. Abew

29' 12' 20.22

الأوامر

chest:

Temp:

(Oral mucositis:

Canula site infection

Q methyl technia

mael r l d e i o'

التاريخ: ١٩٩١ / ١ / ٢٢

الوقت:

توقيع الطبيب :



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجودة

أوامر الطبيب Doctor's Orders

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:
Temp: ER 018 - PR 418
Oral mucositis:
Canula site infection: 218.

- Cg. phesgo SC

- nolvadix 10 mg 1 X 2 X 90 21

Cg. phesgo
Cl. ph. / Phesgo
28/2/2023

التاريخ: / /
الوقت:

توقيع الطبيب: د. / /
C - 02.10/28

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

Cg

Cg. phesgo

Cl. ph.
Phesgo

Cg. phesgo

التاريخ: / /
الوقت:

توقيع الطبيب:
C - 02/29

ع.ع. 31/3/29
فاطمه

سندو - 7/7 - 7/7

ع. + 1 x 1

ع. + 1 x 1

ع. + 1 x 1



وزارة الصحة والسكان
إدارة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :

الرقم الطبي :

الأوامر

chest: EF 63% in 13/4/2023
Temp: 37.5
Oral mucositis: no
Canula site infection: no

7-7-2023

3. Xcxi -

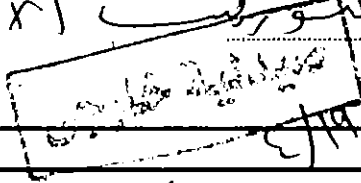
2. Xcxi -

1. Xcxi -

2. Xcxi -

توقيع الطبيب :

التاريخ:
الوقت:



الأوامر

chest: Clophesgo
Temp: 19/4/2023
Oral mucositis: ph/AHMED
Canula site infection: no

7-7-2023

3. Xcxi -

2. Xcxi -

1. Xcxi -

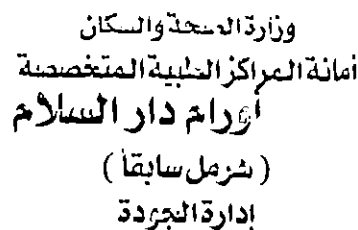
2. Xcxi -

التاريخ:
الوقت:

Clophesgo
16/5
Ahmed Reda

توقيع الطبيب :

7-7-2023



اسم المريض : حميد عبد الباقي
الرقم الطبي : 9999999999

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Cannula site infection:

Handwritten notes on lined paper:

Top left: Handwritten: 31/7

Top right: Handwritten: 31/7

Center: Handwritten: 31/7

Bottom left: Handwritten: 31/7

Bottom right: Handwritten: 31/7

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

سازگی

0/51

chest:			
Temp:			
Oral mucositis:			
Canula site infection:			

Canula site infection

قيد ملزم ك. ع. ل. س. لمدة شهر
 ميا يكتو مرد امدد يوب ملزم
 توقيع الطبيب: د. (تلك) الم
 ٩٦/١
 التاريخ: / /
 الوقت:
 C-٣١ / ٩٦ / ١

اسم المريض ثلاثي: كريمة محمد
رقم الملف: ٢٠٢٢/١٠٠٠



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "

إقرار الموافقة على علاج كيميائي

أقرانا..... ولي أمر الطفل..... الرقم القومي:.....

بأنني قد وافقت على تلقي العلاج الكيميائي لعلاج مرض:

كما أقر بأنني تلقيت شرح شامل ما يلي: -

- طبيعة العلاج الكيميائي المقدم وطرق تلقي العلاج.

- الفوائد المرجوة من العلاج الكيميائي ومدى احتمالية نجاحه.

- المخاطر والمضاعفات المحتملة لتلقي العلاج الكيميائي التي قد تشمل الغثيان والقيء، تساقط الشعر،

الإمساك، الإحساس بالإرهاق، التهابات الفم والجهاز الهضمي، ضعف المناعة، أنيميا، التهاب المثانة،

هشاشة العظام، تأثير وظائف الكلى-الكبد-القلب، العقم عند الذكور ، اضطرابات التبويض عند الإناث.

- البدائل المتاحة للعلاج الكيميائي إن وجدت.

- العواقب المحتملة في حالة رفض العلاج الكيميائي.

وهذا إقرار مني بذلك دون أنني مسنولية على الطبيب أو الطاقم الطبي.

أقر بهذا وأوقع عليه

توقيع ولي أمر الطفل: كريمة محمد صلة القرابة: أم

اسم الطبيب: د. أحمد عبد الله التوقيع: د. أحمد عبد الله

اسم الشاهد: محمد التوقيع: محمد

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٥ الوقت: ١٥:٠٠

ملحوظة: يتم تغيير الإقرار عند تغيير بروتوكول العلاج



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض : صبره محمد بن البشير
الرقم الطبي : ٢٩/٢٩

الأوامر

chest: _____
Temp: _____
Oral mucositis: _____
Canula site infection: _____

صيدلية خارجي

١٢/١٦/٢٥

التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب:

الأوامر

chest: _____
Temp: _____
Oral mucositis: _____
Canula site infection: _____

EF.61.t.

صيدلية خارجي
٢٩/١٧/٢٥

منجر من اتصال

١/٨/٢٥

صيدلية الخارج

التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب:



وزارة الصحة والسكان
إسناد المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شربل سابقاً)
إدارة الجودة

EF (1/8/2023) = 61 %

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض:
الرقم الطبي: ٢٩٢٢/٢٩

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

23/8/2023 Cycle (16)

م. ج. ٢٦ ك. الخلد

ت. كامل وشم. ١٠ ق. ٢٠ يوم

١٠ ق. ٢٠ يوم

١٠ ق. ٢٠ يوم

١٠ ق. ٢٠ يوم

توقيع الطبيب:

C16 ph.

٢٩٢٢/٨/٢٣

صيدلية خارجي
التاريخ: ٢٣/٨/٢٣
الوقت: ١٢:٠٠

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

١٠ ق. ٢٠ يوم

١٠ ق. ٢٠ يوم

١٠ ق. ٢٠ يوم

١٠ ق. ٢٠ يوم

C17 phesgo

١٢/٩

١٢/٩

١٢/٩

١٢/٩

١٢/٩

١٢/٩



وزارة الصحة والشؤون
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شامل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض : هبة السيد الباسط

الرقم الطبي : ٢٩٠٣/٢٢

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

Abulul - Free

BW BB Mmm - -

Free

١٩/٢ مريض

١٩/٢ مريض

١٩/٢ مريض

توقيع الطبيب : ١٩/٢ مريض

التاريخ :
الوقت :

٢٢٢/١٢/١٣

أوامر الطبيب

chest:

Temp: ٣٨.٥

Oral mucositis:

Canula site infection:

١٩/٢ مريض

١٩/٢ مريض

١٩/٢ مريض

١٩/٢ مريض

التاريخ :
الوقت :

توقيع الطبيب : ١٩/٢ مريض



وزارة الصحة والسكان
إسناد المراكز الطبية المتخصصة
أوامر دار السلام
(شربل سابقاً)
إدارة الجودة

أوامر الطبيب Doctor's Orders

اسم المريض :
الرقم الطبي :
2952/CC

الأوامر
22/07
23/07
24/07
25/07
26/07
27/07
28/07
29/07
30/07
31/07
1/08
2/08
3/08
4/08
5/08
6/08
7/08
8/08
9/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
26/08
27/08
28/08
29/08
30/08
31/08
1/09
2/09
3/09
4/09
5/09
6/09
7/09
8/09
9/09
10/09
11/09
12/09
13/09
14/09
15/09
16/09
17/09
18/09
19/09
20/09
21/09
22/09
23/09
24/09
25/09
26/09
27/09
28/09
29/09
30/09
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
11/10
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
31/10
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
13/12
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
19/12
20/12
21/12
22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

توقيع الطبيب :
الوقت :
22/07
23/07
24/07
25/07
26/07
27/07
28/07
29/07
30/07
1/08
2/08
3/08
4/08
5/08
6/08
7/08
8/08
9/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
26/08
27/08
28/08
29/08
30/08
31/08
1/09
2/09
3/09
4/09
5/09
6/09
7/09
8/09
9/09
10/09
11/09
12/09
13/09
14/09
15/09
16/09
17/09
18/09
19/09
20/09
21/09
22/09
23/09
24/09
25/09
26/09
27/09
28/09
29/09
30/09
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
11/10
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
31/10
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
13/12
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
19/12
20/12
21/12
22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12

الأوامر
chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:
توقيع الطبيب :
التاريخ :
الوقت :
22/07
23/07
24/07
25/07
26/07
27/07
28/07
29/07
30/07
1/08
2/08
3/08
4/08
5/08
6/08
7/08
8/08
9/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
26/08
27/08
28/08
29/08
30/08
31/08
1/09
2/09
3/09
4/09
5/09
6/09
7/09
8/09
9/09
10/09
11/09
12/09
13/09
14/09
15/09
16/09
17/09
18/09
19/09
20/09
21/09
22/09
23/09
24/09
25/09
26/09
27/09
28/09
29/09
30/09
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
11/10
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
31/10
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
13/12
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
19/12
20/12
21/12
22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12

وزارة
الصحة العامة

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجودة

أوامر الطبيب Doctor's Orders

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

Dr. Amr

Diagnosis:
Hypertension
مريض بارتفاع ضغط الدم

Medication:
Lisinopril 10mg
مريض بارتفاع ضغط الدم

توقيع الطبيب :
التاريخ: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١
الوقت:

الأوامر

Diagnosis:
Hypertension
مريض بارتفاع ضغط الدم

توقيع الطبيب :
التاريخ: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١
الوقت:



بإمارة وزارة الصحة
أكاديمية التخصصية
أوامر دار السلام
(شامل سابقاً)
إدارة البنية

Doctor's Orders أوامر الطبيب

يضيء

طبيب

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

Break G under Adj. h. 1#

Build STM →

التاريخ: / /
الوقت:

الطبيب: (1)
(2)

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

حالت (1)
بنا (1)
و (1) (1)

أ. طبيب (1)
المرح (1)

11/11/14
11/11/14

التاريخ: / /
الوقت:

الطبيب



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجودة

أوامر الطبيب Doctor's Orders

اسم المريض : حميدة سيد عبدالباق
الرقم الطبي :

الأوامر

chest: ON EX. NAD
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

تامولسفين ٢٠٠

٦ ليوم

١٠٠٠ مل ماء

٢٠٠٠ مل ماء

توقيع الطبيب :

مروان محمد

التاريخ : ١٠/١٢/٢٠١٥
الوقت :

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

توقيع الطبيب :

التاريخ : ١٠/١٢/٢٠١٥
الوقت :

١٠/١٢/٢٠١٥



حميدة محمد عبد الباق

Deen sir,

May I kindly refer to you this 55 year old
Female pt. with left Br. Cancer who received
18 wks Neoadjuvant of Taxol-Carbo + P+H
that ended on 22/12/2022, then underwent
left MRM on 12/1/2023 & was referred to
W for PORT.

Started: 6/4/2023

Ended: 29/4/2023

Received, 40 Gy / 15fx / 3 wks

ط/م/أيتن ط/أ خلد

29/4/2023